PLANO DE ANÚNCIOS PARA CONSULTÓRIO · VERSÃO DE 04/11/2026

Como eu faria seus anúncios de Endocrinologia

Plano para quem tem consultório próprio, continuando o carrossel: a conta, a verba, as campanhas, os criativos e o combinado com a recepção, para endocrinologia.

1 A conta da consulta, antes de qualquer anúncio

Clínica não compra conversa. Clínica compra paciente sentado na cadeira. Por isso a primeira coisa que eu faria é esta conta, com os seus números.

1 O valor da consulta que você cobra

2 menos o que ela custa para você (equipe, aluguel, imposto) = o que sobra

3 Valor da consulta ÷ o que sobra = quanto cada R$ 1 de anúncio precisa voltar para empatar

EXEMPLO, NÃO É NÚMERO SEU

Consulta de R$ 400, sobram R$ 200	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 2**
Com 25% de desconto: consulta de R$ 300, sobram R$ 100	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 3**
R$ 1.000 de verba a R$ 10 por conversa = 100 conversas	**16 consultas realizadas, R$ 6.400 em consultas de R$ 400 (se 40% agendam e 40% comparecem)**

Seus números: consulta R$ _____ · sobra R$ _____ · cada R$ 1 precisa voltar R$ _____

Os 40% são benchmark de mercado (funil 40/40/40, do método de Pedro Sobral): de 100 conversas, 40 agendam, 16 comparecem e 4 fecham tratamento ou procedimento. Serve só para abrir a conversa. Com 60 a 90 dias de campanha, vale o número da sua conta, e só ele.

O que entra na conta nesta especialidade

Endócrino vive de acompanhamento: o paciente volta. A primeira consulta paga a entrada, e o valor mora nos retornos de tireoide, diabetes, peso e hormônios. Conte quantas consultas por ano um paciente faz no seu consultório, com o número da sua agenda, e não use benchmark de terceiro nisso.

2 Onde colocar a verba

Google
vai quem tem urgência. O paciente já está procurando e escolhe quem aparece e responde primeiro.

Meta (Instagram e Facebook)
vai quem tem ticket e precisa de confiança. Antes de vender o preço, eu preciso vender o médico.

Notoriedade
médico já conhecido na cidade rende no Google mesmo com ticket alto.

META PESA MAIS

Em geral, o paciente de endócrino não está em urgência. Ele tenta sozinho por meses, com dieta, suplemento e exame que veio alterado, antes de procurar um médico. Ele decide por confiança no método. Eu colocaria a maior parte na Meta, com vídeo que explica o exame, e usaria o Google para quem já está com o resultado na mão e pesquisa o que significa.

A fatia exata de cada lado eu só fecho com 60 a 90 dias de dado da sua conta. Aqui está o ponto de partida.

3 As 3 campanhas do Google

Volume de busca e custo por clique eu não medi para a sua cidade. Tudo abaixo é para testar, não é dado. Eu começaria em correspondência exata, e abriria para frase só se a exata não gastar a verba.

1. Nome do médico

Quem já ouviu falar de você e vai conferir. Teto de R$ 30 por dia.

- dr. / dra. [seu nome]
- [seu nome] [cidade]
- [nome da clínica] [cidade]

2. Especialidade + cidade

Quem já sabe qual médico procura e está comparando.

- endocrinologista [cidade]
- endocrinologista particular [cidade]
- consulta com endocrinologista [cidade]
- endocrinologista tireoide [cidade]
- endocrinologista diabetes [cidade]
- endocrinologista emagrecimento [cidade]

3. Sintoma

Quem ainda não sabe qual médico resolve. Ele pesquisa o que sente.

- TSH alto
- TSH baixo
- glicose alterada
- pré-diabetes
- hemoglobina glicada alta
- cansaço e ganho de peso
- não consigo emagrecer

Negativar de saída: "dieta", "chá", "suplemento", "receita", "grátis", "SUS".

> Termos de exame, como TSH e glicada, trazem quem tem o resultado na mão. O anúncio dessa busca deve explicar o exame e levar à consulta, sem interpretar o resultado de ninguém.

Destino do clique: o WhatsApp da recepção ou uma página curta com preço, forma de pagamento e endereço. O clique no botão de WhatsApp é a conversão que eu marco.

4 Público e sequência na Meta

Público

Adultos da cidade e do raio. O filtro é o criativo: um para quem tem exame de tireoide alterado, um para glicose e pré-diabetes, um para quem já tentou várias dietas sozinho.

MÊS 1

70% no topo

70% da verba vai para quem ainda não conhece o seu nome, com vídeo que tira dúvida. Os 30% restantes vão para o anúncio de consulta, com preço e forma de pagamento, para quem já viu o vídeo.

Os dois primeiros vídeos do mês são o exame que veio alterado, com o que cada letra mede, e as dietas tentadas sozinho.

MÊS 2 EM DIANTE

60% em remarketing

60% da verba vai para quem já conhece você: quem chamou no WhatsApp (180 dias), quem visitou o site (90 dias) e quem assistiu aos vídeos (30 dias). O topo continua rodando com o resto.

Quem chamou e não marcou vê o vídeo de como funciona o acompanhamento, com valor e frequência de retorno. Quem assistiu ao vídeo de exame vê o anúncio de consulta com horários.

Eu não mexo numa campanha em menos de 72 horas e olho o mês, não o dia. Eu reporto duas medidas lado a lado: conversa iniciada e segunda mensagem enviada. Só a primeira infla.

5 3 ângulos de criativo

Cada um filtra um paciente. Atenção sem filtro traz curioso, e curioso encarece a conversa.

Exame alterado, e agora?

"O seu exame veio com um asterisco. O que ele quer dizer e quando levar a um endocrinologista."

Vídeo com um exame de exemplo na tela, sem dado de paciente. Filtra quem tem o resultado na mão.

Três dietas depois

"Você já tentou três dietas. Esta é a pergunta que eu faço antes de mexer no seu prato."

Vídeo de pergunta e resposta, sem promessa de peso. Filtra quem se cansou de tentar sozinho.

Tireoide em português

"TSH, T4: o que cada letra do seu exame está medindo."

Carrossel didático. Constrói a imagem de quem explica e seleciona o paciente de tireoide.

6 5 dúvidas de paciente para virar conteúdo

1. "Tireoide engorda?"
2. "Glicose 105 é diabetes?"
3. "Por que eu não emagreço comendo pouco?"
4. "Preciso tomar o remédio da tireoide para sempre?"
5. "Pré-diabetes tem volta?"

Cada dúvida vira um vídeo ou carrossel. Toda resposta com número ou critério precisa de fonte que você possa citar. Sem fonte, tira o número e fica o raciocínio.

7 O combinado com a recepção

Eu trabalho com 20 minutos como limite de resposta: quem tem dor costuma chamar mais de um consultório e fecha com quem responde primeiro e já oferece horário.

Quem responde | **Em quanto tempo** | **O que a IA pode fazer sozinha**

A primeira resposta, por escrito

Repetir o que a pessoa pediu, informar o valor e oferecer dois dias e horários. Cadastro e reserva vêm depois da escolha.

Pergunta inicial: "Você tem algum exame recente? Pode mandar uma foto do resultado para o médico ver antes da consulta?"

Urgência e encaixe

Sede intensa com vômito, confusão ou glicose muito alta medida em casa: a recepção não marca. Orienta pronto-socorro.

Marque o retorno antes de o paciente sair da primeira consulta. Em endócrino, quem sai sem retorno marcado pode sumir, e o retorno é onde a conta fecha.

Automático pode ser o aviso de recebimento, a pergunta inicial e o lembrete de horário. Preço, horário e qualquer orientação de saúde saem de uma pessoa ou de um texto que você já aprovou.

8 O que eu NÃO faria, pelo conselho

Base: Resolução CFM 2.336/2023, a vigente. Ela permite informar preço, forma de pagamento e desconto. Continua fora:

- Promessa de resultado, em qualquer forma.
- Antes e depois.
- Nota, estrela ou print de avaliação.
- Chamar alguém de especialista sem o RQE registrado.
- Escassez que não existe. "Últimos horários" só se a agenda estiver fechando de verdade.

Nesta especialidade, o risco mais comum

- Promessa de emagrecimento ou de peso em prazo, como "perca 10 kg".
- Antes e depois de peso, de corpo ou de exame.
- Nome de medicamento como chamada do anúncio. O anúncio vende a consulta. Confirme na íntegra da resolução antes de arriscar.
- Colocar "endocrinologista" no título sem o RQE. Sem ele, use "médico" e descreva a área em que atende.

Antes de subir qualquer anúncio, o texto passa por revisão. Este plano não substitui a leitura da resolução pelo responsável técnico.

E antes da conversa chegar?

O plano cuida do anúncio e da recepção. O Raio-X olha o passo anterior: como o seu consultório aparece hoje no Google e na IA. Leva poucos minutos.

Fazer o Raio-X do meu consultório